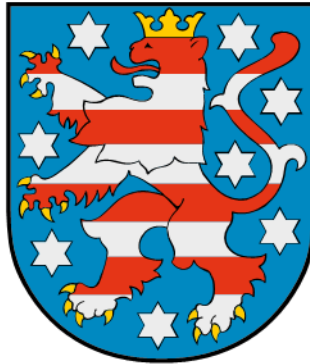




**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Thüringer Handreichung
für die berufsbildende Schule**

Anpassungslehrgang nach § 44 PflAPrV

Pflegefachfrau/Pflegefachmann/Pflegefachperson

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7,
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	4
2. Stundenübersicht.....	5
3. Modul 1: Im Berufsfeld Pflege in Deutschland orientieren.....	6
4. Modul 2: Pflegediagnostik, Pflegeprozess, Pflegekonzept, Qualitätsmanagement und Dokumentation	8
5. Modul 3: Pflegesituationen im Versorgungsbereich Psychiatrie.....	11
6. Modul 4: Pflegesituationen im Versorgungsbereich Pädiatrie	15
7. Modul 5: Pflegesituationen im Versorgungsbereich Krankenhaus.....	18
8. Modul 6: Pflegesituationen im Versorgungsbereich stationäre Langzeitpflege.....	22
9. Modul 7: Pflegesituationen im Versorgungsbereich ambulante Pflege.....	27

1. Vorbemerkungen

Die vorliegende Handreichung dient der strukturierten Umsetzung des Anpassungslehrgangs nach § 44 der Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV). Zielgruppe sind Personen, die im Rahmen eines Anerkennungsverfahrens eine teilweise Gleichwertigkeit ihres ausländischen Berufsabschlusses im Bereich der Pflege erhalten haben und nun die erforderlichen Kompetenzen zur vollständigen Anerkennung in Deutschland erwerben müssen.

Der Schwerpunkt des Anpassungslehrgangs liegt in der praktischen Tätigkeit. Hier sollen die Teilnehmenden insbesondere die unterschiedlichen Versorgungsbereiche der Pflege kennenlernen und das Berufsbild der Pflegenden in Deutschland im Sinne der Generalistik verstehen.

Die vorliegende Handreichung umfasst sieben Module, in denen die inhaltlichen Anforderungen und Lernziele des Anpassungslehrgangs transparent und praxisorientiert dargestellt sind. Die Module orientieren sich an beruflichen Handlungssituationen der generalistischen Pflege. Neben dem Pflegeprozess werden fachliche, kommunikative, rechtliche und ethische Kompetenzen berücksichtigt, die für eine professionelle Pflegepraxis in Deutschland unerlässlich sind. Insofern gibt diese Handreichung den Rahmen für die theoretische Begleitung des Anpassungslehrgangs sowie des sich anschließenden Abschlussgesprächs vor.

Der Anpassungslehrgang versteht sich nicht nur als formale Voraussetzung zur Berufsanerkennung, sondern auch als Chance zur fachlichen Weiterentwicklung und zur erfolgreichen Integration in das deutsche Gesundheits- und Pflegewesen. Die Handreichung soll dabei als verlässliche Grundlage dienen – für Teilnehmende, für anleitende Einrichtungen sowie für Lehrende und Prüfende.

Die Bildungseinrichtungen wählen geeignete Methoden bei der Bearbeitung der exemplarischen Pflegesituationen, die sich an den Vorerfahrungen und Bedarfen der Teilnehmenden orientieren. Dabei können Phasen des selbstgesteuerten Lernens, digitale Lernformate sowie Praxisaufträge genutzt werden.

Wir wünschen allen Beteiligten einen erfolgreichen Verlauf der Anpassungsqualifizierung und danken den Einrichtungen, Lehrkräften und Praxisanleitenden für ihr Engagement bei der Umsetzung dieser bedeutsamen Aufgabe.

2. Stundenübersicht

Modul	Modultitel	UE
1	Im Berufsfeld Pflege in Deutschland orientieren	20
2	Pflegediagnostik, Pflegeprozess, Pflegekonzept, Qualitätsmanagement und Dokumentation	40
3	Pflegesituationen im Versorgungsbereich Psychiatrie	30
4	Pflegesituationen im Versorgungsbereich Pädiatrie	20
5	Pflegesituationen im Versorgungsbereich Krankenhaus	30
6	Pflegesituationen im Versorgungsbereich stationäre Langzeitpflege	30
7	Pflegesituationen im Versorgungsbereich ambulante Pflege	30
		<u>200</u>

3. Modul 1:

Im Berufsfeld Pflege in Deutschland orientieren

Lerninhalte

Im Berufsfeld Pflege in Deutschland orientieren	20 UE
Grundlagen der sozialen Sicherung und Gesundheitspolitik	
• Sozialstaatsprinzip • 5 Säulen der Sozialversicherung in Deutschland • Einrichtungen des Gesundheitssystems (z. B. RKI) • Public Health unter Berücksichtigung von Disease Management Programmen (DMP)	
Pflegesettings in Deutschland im Überblick	
• Stationäre Akutpflege: ○ Definition (§ 107 Abs.1 SGB V), Aufgabenschwerpunkte ○ therapeutische, diagnostische, pflegerische Abteilungen eines Krankenhauses im Überblick ○ Einblick in Arbeitsbedingungen, Tätigkeiten der Pflegenden ○ Aufbau- und Ablauforganisation • Stationäre Langzeitpflege: ○ Definition (§ 71 Abs.2 SGB XI), Aufgabenschwerpunkte ○ Einblick in Arbeitsbedingungen, Tätigkeiten der Pflegenden • Ambulante Pflege: ○ Definition (§ 71 Abs.1 SGB XI), Aufgabenschwerpunkte ○ Einblick in Arbeitsbedingungen, Tätigkeiten der Pflegenden	
Überblick über Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer	
• Tarifverträge und Arbeitsvertragsrichtlinien • Betriebsverfassungsgesetz (Personal) • Pflegeberufegesetz (Vorbehaltstätigkeiten) • Schutzgesetze: Arbeitszeitregelungen, Urlaub, Mutterschutzregelungen • besondere Pflichten als Mitarbeitende im Gesundheitswesen: Impfungen, Belehrungen im Umgang mit Lebensmitteln und Hygiene, Schweigepflicht und Datenschutz • Weisungsbefugnis durch den Arbeitgeber (Direktionsrecht), Delegation	
Pflegekompetenz und berufliche Handlungskompetenz	
• Begriffsklärung	

4. Modul 2:

**Pflegediagnostik, Pflegeprozess,
Pflegekonzept,
Qualitätsmanagement und
Dokumentation**

Lerninhalte

Pflegediagnostik, Pflegeprozess, Pflegekonzept, Qualitätsmanagement und Dokumentation		40 UE
Pflegeprozess		
• Pflegeprozess nach Fiechter und Meier • Grundlagen der Pflegeplanung ○ Definition ○ Aufgaben ○ Struktur • Pflegebedarf diagnostizieren ○ Pflegeanamnese und Pflegeassessment ○ Instrumente (SIS und ABEDL) • Erhebung von Pflegediagnosen ○ Definition Pflegediagnose nach NANDA ○ Einteilung ○ Aufbau • Ressourcen • Formulieren von Pflegezielen und Pflegemaßnahmen • Durchführen der Pflegeinterventionen und Evaluation • Grundlagen der Pflegedokumentation		
Expertenstandards nach DNQP		
• Expertenstandards nach DNQP ○ Definition und Ziele ○ Aufbau ○ Abgrenzung Expertenstandard/Pflegestandard • Qualitätskriterien der Expertenstandards nach DNQP • bestehende Expertenstandards im Überblick • Umsetzungsmöglichkeiten in der pflegerischen Praxis		
Pflege-theorien und -konzepte im Überblick		
• Gestaltung eines Praxisauftrags in Anlehnung an das bestehende Pflegeleitbild des Ausbildungsträgers		

Qualitätsmanagement

- Definition
- Qualitätsentwicklung (PDCA-Zyklus)
- Pflegequalität
 - Definition
 - Merkmale
- Instrumente der internen und externen Qualitätssicherung (z. B. Leitbild, Pflegestandards, Qualitätszirkel, Einarbeitungskonzepte, Fehlermanagement, Fort- und Weiterbildung)
- nationale Verbände und Organisationen der Pflege

5. Modul 3:

Pflegesituationen im Versorgungsbereich Psychiatrie

Pflegesituation

Die stille Frau Leise (Ankündigung Suizidversuch)

Im Rahmen Ihres Anpassungslehrgangs für die Anerkennung Ihrer ausländischen Berufsqualifikation als Pflegefachkraft arbeiten Sie seit zwei Wochen auf der handchirurgischen Station des städtischen Klinikums.

Heute haben Sie mit Schwester Bärbel Spätdienst und 29 Pflegeempfänger zu versorgen. In der Abendrunde gehen Sie zu Frau Leise, einer 68jährigen Frau, die im Laufe ihres Lebens viele Schicksalsschläge verkraften musste. Da ihre Mutter starb, als sie 6 Jahre alt und der Vater mit der Situation überfordert war, wuchs sie im Kinderheim auf. Mit 18 Jahren lernte sie ihren späteren Mann kennen, den sie bald darauf heiratete und zwei Söhne zur Welt brachte.

Vor drei Jahren starb der Mann nach langer Pflegezeit an Krebs und zwei Jahre darauf ihr Sohn an den Folgen einer schweren Erkrankung. Zu ihrem zweiten Sohn hat sie seit Jahren keinen Kontakt mehr. Das alles hat Frau Leise stark mitgenommen, sie denkt viel über ihr Leben nach und möchte allein sein. Manchmal hat sie keine Lust aufzustehen und rauszugehen. Ihre sozialen Kontakte beschränken sich auf ihre Schwester, die zwei Stunden entfernt wohnt und mit der sie wöchentlich einmal telefoniert, sowie ihren Nachbarn, der für sie wichtige Besorgungen erledigt.

In der Pflegedokumentation ist vermerkt, dass Frau Leise sich jeden Tag mehr in sich zurückzieht. Auch isst sie immer weniger. Als Sie ihr heute das Abendbrot ins Zimmer stellen und fragen, welchen Tee sie trinken möchte, antwortet sie: „Gar keinen. Ich will nicht mehr. Am besten, ich springe jetzt aus dem Fenster.“

Sie sind total verunsichert und trauen sich nicht, Frau Leise alleine zu lassen. Sie klingeln nach Schwester Bärbel und erzählen ihr davon. Die Zimmertür lassen Sie leicht geöffnet, um Frau Leise im Blick zu haben. Schwester Bärbel bittet sie, bei Frau Leise zu bleiben und diese auch nicht allein auf Toilette zu lassen, bis sie wiederkommt. In der Zwischenzeit wird sie Meldung machen.

Es dauert lange bis ein Arzt kommt, den Sie hier noch nie gesehen haben, um sich mit Frau Leise zu unterhalten. Er vermutet eine ausgeprägte Depression bei Frau Leise. Sie wird auf die IMC verlegt, ehe dort am nächsten Tag entschieden wird, wie es für sie weitergeht. Sie verabschieden sich von ihr und wünschen ihr alles Gute.

Jetzt wollen Sie viele Informationen von Schwester Bärbel einholen, um nachvollziehen zu können, was sie während dieser langen Zeit alles organisieren musste und warum.

Lerninhalte

Versorgungsbereich Psychiatrie	30 UE
Ankündigung Suizidversuch	
• Pflegediagnose: Risiko für suizidales selbstverletzendes Verhalten ○ Risikofaktoren ○ Risikogruppen ○ Anwendung auf die Handlungssituation • Begriffsbestimmung Suizid einschließlich Suizidformen und präsuizidales Syndrom mit Anwendung auf die Handlungssituation • pflegerische Beobachtungsschwerpunkte, Maßnahmen und Umgang mit Suizidanten in der ambulanten und stationären Akut- und Langzeitpflege ○ bei Ankündigung ○ nach erfolglosem Suizidversuch ○ Fixierung als freiheitsentziehende Maßnahme (unter Beachtung von GG, PsychKG, StGB) ▪ Formen freiheitsentziehender Maßnahmen ○ nach erfolgreichem Suizidversuch ○ Anwendung/Reflexion auf die Handlungssituation • Suizidprävention in der ambulanten und stationären Akut- und Langzeitpflege	
Depression	
• Pflegediagnose: Ausgeprägte Einsamkeit ○ bestimmende Merkmale ○ beeinflussende Faktoren ○ Risikogruppen ○ Anwendung auf die Handlungssituation • Erkrankungsbild Depression systematisch darstellen ○ affektive Störung ▪ Begriffsbestimmung ▪ Verlaufsformen ○ Epidemiologie ▪ Prävalenz, Inzidenz ▪ Altersverteilung ○ multifaktorielle Ursachen ▪ Vulnerabilitäts-Stress-Konzept, psychosoziale Faktoren ○ Symptome und Depressionsspirale	

- Anwendung auf die Pflegesituation
- Therapie, z. B.
 - Psychotherapie
 - medikamentöse Therapie
 - Schlafentzug
 - psycho-soziale Therapiemöglichkeiten
- pflegerische Beobachtungsschwerpunkte, Maßnahmen und Umgang mit depressiven Pflegeempfängern in der ambulanten und stationären Akut- und Langzeitpflege
 - inkongruentes Verhalten und Äußerungen, Medikamentennebenwirkungen
 - entlastende und aktivierende Pflege
 - Förderung der Schlafhygiene
 - ggf. Durchführung von Prophylaxen, z. B.
 - Mangelernährung
 - Dekubitus
 - Pneumonie
 - wertschätzende Kommunikation nach Rogers
 - Tagesstrukturierung

6. Modul 4:

Pflegesituationen im Versorgungsbereich Pädiatrie

Pflegesituation

Lukas wird operiert

Seit einigen Tagen absolvieren Sie ein Praktikum auf der pädiatrischen Station eines Krankenhauses. Heute begleiten Sie die Pflegefachkraft Anna bei ihrer morgendlichen Runde.

Eines der Kinder, das Sie heute betreuen, ist Lukas, 3 Jahre alt. Lukas wurde gestern aufgenommen, da bei ihm eine Tonsillektomie geplant ist. Er ist sehr lebhaft, neugierig, aber auch ängstlich, da er die fremde Umgebung nicht kennt.

Seine Mutter wurde als Begleitperson mit aufgenommen und schläft auf dem Elternbett im Zimmer. Sie wirkt fürsorglich, aber selbst angespannt, da sie sich Sorgen um die bevorstehende Operation macht.

Sie beobachten, dass Lukas sich an seine Mutter klammert, nicht gerne alleine mit dem Pflegepersonal sein möchte und auch keine Antworten an das Pflegepersonal auf Nachfragen gibt. Die Mutter wirkt auf Sie sehr besorgt, sie stellt viele Fragen zum Ablauf der Operation, zur Narkose und zur notwendigen Nachbehandlung. Sie sagt wiederholt, dass sie nichts falsch machen möchte und Lukas große Angst vor Schmerzen hat.

Durch die Beobachtungen erkennen Sie, dass die Eltern-Kind-Bindung einen wichtigen Stellenwert in der pädiatrischen Pflegearbeit hat und dass die Pflegekräfte nicht nur medizinische Aufgaben haben, sondern auch pädagogische und psychosoziale Verantwortung übernehmen.

Sie nehmen sich vor, mit Ihren Kollegen über die Unterschiede zwischen der Pflege von Kindern und Erwachsenen im Krankenhaus zu sprechen und auf die Bedeutung der Kommunikation/Interaktion mit Eltern und mit dem Kind detailliert einzugehen.

Lerninhalte

Versorgungsbereich Pädiatrie		20 UE
rechtliche Grundlagen in der pädiatrischen Versorgung		
• Überblick zu gültigen gesetzlichen Grundlagen: ○ Kinderrechte und Schutzgesetze ○ UN-Kinderrechtskonvention ○ EACH-Charta ○ Sorgerecht ○ Aufnahme von Begleitpersonen (§ 11 Abs. 3 SGB V)		
pflegerische Unterstützung bei Kindern/Jugendlichen und ihren Bezugspersonen leisten		
• Erkennen von Belastungsfaktoren • prä- und postoperative Pflegemaßnahmen ○ entwicklungsorientierte Vorbereitung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen bei invasiven Maßnahmen unter Berücksichtigung der emotionalen und kognitiven Entwicklung • Beziehungsgestaltung und Gestaltung entwicklungsorientierter Kommunikation • familienzentrierte Pflege und Elternarbeit		
Schmerz		
• Schmerzmanagement bei akuten Schmerzen		

7. Modul 5:

Pflegesituationen im Versorgungsbereich Krankenhaus

Pflegesituation

Herr Sommer hat ein geschwächtes Herz.

Herr Sommer ist 59 Jahre alt und leidet schon seit mehreren Jahren an einer Linksherzinsuffizienz mit Rasselgeräuschen in der Lunge, Belastungsdyspnoe, eingeschränkter Leistungsfähigkeit und schneller Ermüdung. Nach einigen Jahren medikamentöser Therapie bemerkt er nun deutliche körperliche Veränderungen. Seine Beine und Füße sind abends vermehrt geschwollen, sodass Schuhe und Socken an Beinen und Füßen einschnüren. Zudem hat er in den letzten Wochen an Gewicht zugenommen, was er aber auf die ungesunde Ernährung an stressigen Arbeitstagen schiebt. Mit dem Rauchen hat er auch wieder angefangen.

Während seiner Arbeit als Schichtleiter in der Lagerwirtschaft wird ihm plötzlich schwindelig. Er entwickelt starke Luftnot und Husten, wird blau im Gesicht und drückt die Hände gegen seine schmerzende Brust. Ein aufmerksamer Kollege wählt den Notruf 112.

Herr Sommer wird nach der Versorgung in der Notaufnahme des städtischen Krankenhauses mit der Diagnose „Dekompensierte globale Herzinsuffizienz (NYHA III) und Lungenödem“ auf die kardiologische Station verlegt.

Am nächsten Morgen übernehmen Sie als Pflegefachperson die Versorgung von Herrn Sommer und ermitteln folgende Parameter: Puls 140/min, Blutdruck 90/55 mmHg, atemabhängige Schmerzen in der Brust (NRS: 4) und eine Sauerstoffsättigung von 98% unter 3 Liter Sauerstoff pro Minute via Nasenbrille. Sie verabreichen Herrn Sommer die verordneten Diuretika über eine Venenverweilkanüle an der rechten Hand. Sie bemerken bei Herrn Sommer Dyspnoe und Unruhe. Er kann durch die ärztlich verordnete Bettruhe nicht mehr auf dem flachen Rücken liegen. Sie positionieren den adipösen Patienten zur Atem erleichterung in eine Oberkörperhochlage. Herr Sommer blickt Sie dankbar und erleichtert an. Sie informieren ihn, dass er zunächst im Bett liegen bleiben soll, bis sich seine Vitalparameter wieder verbessert haben. Sie erklären Herrn Sommer, dass die Urinausscheidung durch die Diuretika-Gabe deutlich gesteigert wird und er sich rechtzeitig über die Patientenklingsel melden soll. Nur so kann er die notwendige Unterstützung von den Pflegenden erhalten, um sich auch weiterhin körperlich zu schonen. Während dessen Sie Herrn Sommer ein Glas Wasser zum Trinken reichen, informieren Sie ihn über die ärztlich verordnete Trinkmengenbeschränkung von maximal 1,5 Liter pro Tag. Sie notieren die eingenommene Trinkmenge auf dem bereitgelegten Bilanzbogen.

Nach der Bereitstellung der benötigten Materialien unterstützen Sie Herrn Sommer bei der Körperpflege mit Pflegeutensilien der Klinik im Bett. Herr Sommer putzt seine Zähne, die Pflege der unteren Zahnteilprothese übernehmen Sie. Er kleidet sich mit Ihrer Unterstützung

aus und wäscht sein Gesicht selbst. Danach bemerken Sie eine Erschöpfung und zunehmende Verschlechterung seines Atemzustands und übernehmen nach einer kurzen Pause die weitere Körperpflege von Herrn Sommer. Die von Ihnen durchgeführte atemstimulierende Einreibung wird vom Patienten als angenehm empfunden. Bei der Körperpflege integrieren Sie die Hautinspektion und stellen dabei folgendes fest: feuchte Haut (besonders in den Hautfalten an Achseln und Bauch), beidseits ödematöse Unterschenkel und Füße mit sehr trockener Haut und eine Rötung der Haut im Sakralbereich. Der durchgeführte Fingertest ist negativ. Sie informieren den Patienten und leiten weitere notwendige Pflegemaßnahmen ein.

Trotz eingeleiteter Folgemaßnahmen zur Dekubitusprophylaxe und gelockerter Bettruhe entwickelt Herr Sommer in den Folgetagen einen Sakraldekubitus Kategorie 2. Bei der Wundversorgung äußert Herr Sommer Schmerzen an der Wunde und Sie bemerken eine Rötung und Schwellung der Wundränder sowie eitriges Wundsekret. Nach einem ärztlich angeordneten bakteriologischen Abstrich der Wunde wird eine MRSA-Infektion festgestellt. Zudem wird im Perineal-Bereich und im Nasen-Rachen-Raum von Herrn Sommer eine MRSA-Kolonisation festgestellt. Sie leiten nun alle notwendigen Maßnahmen zur ärztlich verordneten MRSA-Sanierung und Isolation ein und klären Herrn Sommer entsprechend auf.

Lerninhalte

Versorgungsbereich Krankenhaus	30 UE
Herzinsuffizienz	
• das Krankheitsbild Herzinsuffizienz systematisch darstellen ○ Definition, Begriffsbestimmung der WHO ○ Ursachen, Risikofaktoren ○ Einteilung der Herzinsuffizienz (nach Kompensation, nach Lokalisation, nach Krankheitsverlauf, NYHA-Klassifikation) ○ Leitsymptome der Links- und Rechtsherzinsuffizienz ○ Therapie	
Pflegeplanung	
• Erstellung einer Pflegeplanung (PESR-Schema) zur Pflegesituation mit Integration von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention unter Berücksichtigung folgender Pflegeschwerpunkte: ○ Haut- und Körperpflege ○ Dekubitusprophylaxe ○ Thromboseprophylaxe ○ Dehydratationsprophylaxe ○ Pneumonieprophylaxe ○ Intertrigoprophylaxe ○ Infektionsprophylaxe ○ Soor- und Parotitisprophylaxe	
MRSA	
• Bedeutung von MRSA im Zusammenhang mit nosokomialen Infektionen, Risikopopulationen und Meldepflicht • Überblick zu Übertragungswegen • Therapie/MRSA-Sanierung • Isolations- und Hygienemaßnahmen	
Medikamentenmanagement	
• Beschreibung von Pflegemaßnahmen im Zusammenhang mit der Verabreichung ärztlich verordneter Medikation unter Berücksichtigung der 12-R-Regel	
Beratung	
• Strategien, um eine geeignete Atmosphäre für eine Beratung zu ermöglichen • Beratung zur Symptomkontrolle an der Pflegesituation orientiert	

8. Modul 6:

Pflegesituationen im Versorgungsbereich stationäre Langzeitpflege

Pflegesituation

Frau Winter – Seniorin in der stationären Langzeitpflege

Frau Renate Winter (83 Jahre) lebt seit etwa einem Jahr im Altenpflegeheim „Am Wald“. Ihre aufgeschlossene und freundliche Art wird von den Bewohnern des Wohnbereichs, aber auch von den Pflegekräften sehr geschätzt. Für jeden findet Frau Winter ein paar aufbauende Worte und schenkt anderen gern ein Lächeln. Sie ist verwitwet und hat keine Kinder, aber eine Nichte, die sie regelmäßig besucht.

Frau Winter leidet schon lange Zeit an rheumatoider Arthritis, die ihre Gelenke, insbesondere in den Händen und Füßen, stark beeinträchtigt hat. Trotz medikamentöser Therapie nehmen die Einschränkungen in der Beweglichkeit immer mehr zu und auch die Schmerzen sind zeitweise kaum erträglich. Fortschreitende Deformierungen an den Gelenken sorgen dafür, dass ihre Feinmotorik immer stärker eingeschränkt ist. Teilweise fällt es Frau Winter schwer Gegenstände zu greifen, Knöpfe zu schließen oder einfachste Tätigkeiten auszuführen.

Hinzu kommt eine Altersbedingte Makuladegeneration (AMD), die ihr zentrales Sehfeld beeinträchtigt. Bisher können die Symptome durch eine Brille teilweise kompensiert werden, doch ist das Sehen schon eingeschränkt, weshalb Frau Winter manchmal Hindernisse übersieht und auch nicht gleich erkennt, wer mit ihr spricht.

Ein weiteres Thema ist ihre Dranginkontinenz. Diese versorgt Frau Winter gut selbst, indem sie rechtzeitig die Toilette aufsucht und Einlagen benutzt. Doch manchmal schafft sie den Weg ins Bad nicht rechtzeitig. In diesen Momenten schämt sie sich, was sie auch dem Pflegepersonal gegenüber äußert.

Trotz dieser körperlichen Einschränkungen ist Frau Winter geistig fit, sehr freundlich und humorvoll. Sie legt großen Wert darauf, so weit wie möglich am Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Sie liebt es, an den täglichen Aktivitäten, wie zum Beispiel Singstunden oder kreativen Nachmittagen, teilzunehmen. Allerdings muss sie bei längeren Strecken, etwa vom Zimmer zum Gemeinschaftsraum, im Rollstuhl geschoben werden, da die Gehbeschwerden durch die Arthritis zu groß sind.

Im Alltag benötigt Frau Winter Unterstützung bei der Körperpflege, insbesondere beim Waschen sowie beim Kleiden, da das An- und Ausziehen aufgrund der steifen Gelenke und der eingeschränkten Fingerfertigkeit schmerzhaft und schwierig ist. Bei der Zubereitung der Mahlzeiten ist sie ebenfalls auf Hilfe angewiesen, vor allem beim Schneiden und Zerkleinern der Speisen. Auch benötigt sie Hilfe beim Öffnen von Flaschen o. ä.

Frau Winter empfindet ihre Abhängigkeit von den Pflegenden manchmal als sehr störend und entschuldigt sich, ihnen so sehr zur Last zu fallen. Doch ist sie sehr erleichtert, so gut versorgt

zu werden. Sie weiß, dass sie die nötige Hilfe bei den alltäglichen Dingen bekommt, die sie zu Hause nicht mehr hätte leisten können. Sie schätzt die Freundlichkeit des Pflegepersonals und das Gemeinschaftsgefühl, das sie in den gemeinsamen Aktivitäten erlebt.

Psychosoziale Aspekte

Der Einzug ins Pflegeheim fiel ihr damals sehr schwer. Nur ungern hat sie sich von dem kleinen Häuschen getrennt, welches sie mit ihrem geliebten Mann Erwin selbst gebaut hat. Zusammen haben sie sich auch um den gemeinsamen Garten gekümmert und um ihre geliebten Rosen. Nach dem Tod ihres Mannes vor vier Jahren bewohnte sie das Haus allein, wobei es manchmal sehr „leer und einsam“ wirkte. Die Tatsache, dass sie und ihr Mann nie selbst Kinder hatten, verstärkte das Gefühl des Verlusts und der Einsamkeit. Doch die Rosen im Garten haben sie immer an ihren Erwin erinnert und wenn sie davon erzählt, schwingt jedes Mal ein Gefühl von Melancholie mit.

Engagement im Heimbeirat

Trotz ihrer zunehmenden körperlichen Einschränkungen engagiert sich Frau Winter stark im Heimbeirat. Sie vertritt dort die Interessen der anderen Bewohner und ist eine geschätzte Ansprechpartnerin für die Heimleitung. Dieses Engagement ist für sie sehr wichtig, da es ihr ein Gefühl von Sinn und Teilhabe am Heimleben gibt. Es fordert sie geistig und ermöglicht ihr, soziale Kontakte zu pflegen.

Diskussion im Pflorgeteam

In jüngster Zeit hat sich Frau Winters Zustand weiter verschlechtert, was die Einschränkungen ihrer Beweglichkeit und Feinmotorik betrifft. Dies führt dazu, dass sie auch bei kürzeren Strecken im Zimmer unsicher wird und vermehrt Unterstützung benötigt. Im Pflorgeteam wird daher diskutiert, ob die bisherige Einstufung in Pflegegrad 2 noch den tatsächlichen Pflegebedarf abbildet oder ob eine Höherstufung erforderlich ist. Die Begründung für die Überlegung liegt in der zunehmenden Schwere der Beeinträchtigung ihrer Selbstständigkeit in den Bereichen Mobilität und Selbstversorgung, die durch die fortschreitende Arthritis und die Makuladegeneration noch verstärkt werden. Das Team bereitet sich darauf vor, eine detaillierte Dokumentation zu erstellen, um die Beantragung der Höherstufung zu untermauern.

Lerninhalte

Versorgungsbereich stationäre Langzeitpflege	30 UE
Pflegebedürftigkeit und Pflegegrad	
• Begriff der Pflegebedürftigkeit nach § 14 SGB XI • Voraussetzungen zur Beantragung eines Pflegegrads • Beantragung eines Pflegegrads/Höherstufung eines bestehenden Pflegegrads • Leistungen der Pflegeversicherung ○ Entlastungsbetrag ○ Leistungen der stationären Pflege ○ Hilfsmittel	
vertragliche Regelung der Pflegebeziehung in stationären Pflegeeinrichtungen	
• Wohn- und Betreuungsvertrag ○ Zustandekommen ○ Inhalte (Rechte und Pflichten Heimträger und Bewohner) • Heimkosten ○ Zusammensetzung der Heimkosten ○ Problematik steigender Heimkosten und Folgen für Bewohner sowie Bezugspersonen • Partizipation der Bewohner ○ Heimbeirat	
Biografiearbeit	
• Ziele/Bedeutung • Möglichkeiten zur Erhebung • Integration der individuellen Biografie der Bewohner in das eigene Pflegehandeln	
Strukturierte Informationssammlung (SIS) und individuelle Maßnahmenplanung (IMP)	
• Aufbau • Integration in den Pflegeprozess • Anwendung auf die Pflegesituation	

Inkontinenz

- Bedeutung und Folgen für den Pflegebedürftigen
- Expertenstandard „Kontinenzförderung in der Pflege“
 - Kontinenzprofile
 - Zielstellung pflegerischer Maßnahmen
 - Hilfsmittel bei bestehender Inkontinenz
- Kommunikationsstrategien für die Interaktion mit Pflegebedürftigen bei Einschränkungen der Selbstständigkeit und in belastenden Situationen

Altersbedingte Makuladegeneration, rheumatoide Arthritis

- Erkrankungsbilder des alten Menschen systematisch (Definition, Ursachen, Symptome, Therapie, Komplikationen) darstellen und deren Einfluss auf das Selbstbild und die Selbstständigkeit Betroffener erfassen
 - Altersbedingte Makuladegeneration (AMD)
 - rheumatoide Arthritis
- pflegerische Unterstützung von Menschen mit AMD und rheumatoider Arthritis

9. Modul 7:

Pflegesituationen im Versorgungsbereich ambulante Pflege

Pflegesituation

Frau Krause – Seniorin in der ambulanten Pflege

Seit einigen Wochen absolvieren Sie ein Praktikum im ambulanten Pflegedienst des DRK.

Heute Morgen begleiten Sie die Pflegefachkraft Diana auf ihrer Tour. Nachdem Sie bereits einige Klienten versorgt haben, fahren Sie zu Frau Krause. Diese wird normalerweise nur einmal wöchentlich vom Pflegedienst besucht, um Hilfestellung beim Duschen zu erhalten. Ansonsten kümmert sich Frau Krauses Tochter um die pflegerische Versorgung und alle weiteren Belange. Frau Krause ist 82 Jahre alt und hat derzeit den Pflegegrad 2.

In letzter Zeit haben die Pflegekräfte eine Veränderung bei Frau Krause bemerkt. Sie spricht nicht mehr so viel wie früher und manche Dinge scheint sie nicht so richtig zu verstehen. Heute Morgen kommen Sie etwas früher als sonst bei Familie Krause an. Sie klingeln und zunächst öffnet niemand die Tür. Dann erscheint die Tochter von Frau Krause mit Tränen in den Augen. Sie weint und ist sehr aufgeregt. Während Diana versucht, die Tochter zu beruhigen, gehen Sie weiter ins Badezimmer, um nach Frau Krause zu schauen.

Diese steht mit Stuhlgang beschmiert vor dem Spiegel und versucht, sich mit dem bereits verschmutzten Handtuch zu säubern. Langsam gehen Sie auf Frau Krause zu und lassen Wasser ins Waschbecken ein. Sie ist verwirrt und redet kaum. Es dauert eine Weile, bis Sie Frau Krause gewaschen und frisch gekleidet haben.

Zurück im Auto berichtet Diana von dem Gespräch mit der Tochter: „Frau Krause ist wohl schon die ganze letzte Zeit verändert. Die Tochter meint, dass sie sie zum Teil gar nicht erkennt. Sie verwechselt Kleidungsstücke, versteckt Nahrungsmittel in den Schränken oder lässt die Wohnungstür aufstehen. Die Tochter wirkt völlig überfordert, aber sie möchte ihre Mutter auch auf keinen Fall in ein Pflegeheim geben. Leider gibt es auch keine anderen Familienangehörigen, die sie um Hilfe bitten kann. Ach Mann, und nun sind wir auch noch ziemlich spät dran. Die nächsten Klienten warten sicher schon auf uns.“

Sie schauen aus dem Fenster und denken an Frau Krause. Wie das wohl weitergehen wird mit ihr und wie traurig es ist, wenn ein Mensch sich nach und nach so selbst verliert.

Lerninhalte

Versorgungsbereich ambulante Pflege	30 UE
Organisation eines ambulanten Pflegedienstes	
• mögliche Träger • gesetzliche Grundlagen • Hierarchien • Konzepte und Spezialisierungen	
vertragliche Regelung der Pflegebeziehung in der ambulanten Pflege	
• Vertragsgestaltung mit den Klienten • Leistungskomplexe der Pflegedienste • Leistungen der Pflegeversicherung bzw. anderer Sozialversicherungen	
Perspektiven der ambulanten Pflege	
• Diskussion von Vor- und Nachteilen der ambulanten Pflege für den Klienten, einschließlich der Betrachtung folgender Aspekte: ○ bedürfnisgerechte Beschäftigung ○ Wohnraumanpassung ○ Aufrechterhalten sozialer Kontakte ○ technische Unterstützungsmöglichkeiten	
Herausforderungen der Mitarbeitenden in der ambulanten Pflege	
• kritische Betrachtung der Herausforderungen für Pflegenden im ambulanten Setting unter Berücksichtigung unterschiedlicher Qualifikationsniveaus ○ allgemeine Probleme und Herausforderungen während der täglichen Arbeit ○ körperliche sowie seelische Probleme und Herausforderungen ○ Wohnraumdesorganisation ○ sexuelle Übergriffe ○ selbst- und fremdgefährdendes Verhalten	
pflegende Angehörige in der ambulanten Versorgung	
• Situation pflegender Angehöriger • Rechte pflegender Angehöriger ○ Vollmachten ○ Betreuungsrecht ○ Pflegezeitgesetz • Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige	

Demenz

- Erkrankungsbild Demenz systematisch darstellen
 - Definition und Epidemiologie
 - Überblick zu den Formen der Demenz
 - Morbus Alzheimer
 - vaskuläre Demenz
 - senile Demenz
 - Stadieneinteilung nach der GDS-Reisberg-Skala
 - Diagnostik
 - Therapie
 - begünstigende und hemmende Faktoren
- Überblick zum Expertenstandard „Beziehungsgestaltung bei der Pflege von Menschen mit Demenz“